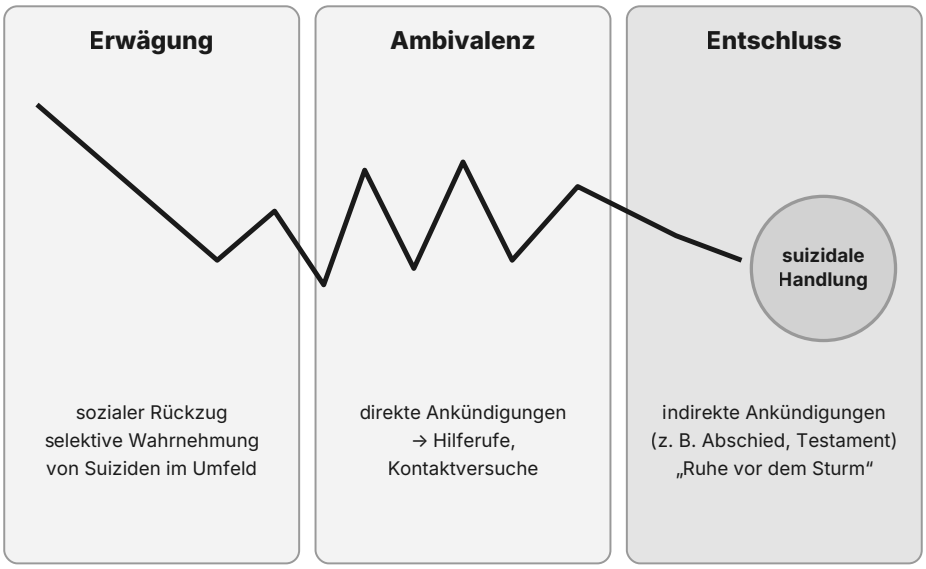
Suizidalität & Suizidprävention

Erkennen, ansprechen, schützen – nach Folien „Suizidalität/Suizidgefahr“, NVL Kap. 12, WHO-Bericht und Medienempfehlungen

Begriffe · Risikofaktoren · Schutzfaktoren · Stadien · Ambivalenz · Alarmzeichen · Ansprechen · Ausprägungsstufen · Bezugspflege · Notfallplan · Antisuizidpakt · Nachsorge · Werther-Effekt · Prävention



Pendeln zwischen Leben und Sterben ↔ hier ist Hilfe am besten möglich

INHALTE DIESES LERNHEFTS

- Begriffe und Sprache
- Zahlen und Risikogruppen
- Risiko- und Schutzfaktoren
- Stadien der suizidalen Entwicklung
- Alarmzeichen
- Einschätzen und offen ansprechen
- Maßnahmen der Bezugspflege
- Notfallplan und Antisuizidpakt
- Nach einem Suizid auf Station
- Medien, Werther-Effekt, Prävention, Übungsfragen 20–24

Quellen: M. Pahler, CE 11.3 Ausweglos? – Suizidalität/Suizidgefahr (Folien, BBG); NVL Unipolare Depression 3.2, Kap. 2.7 und 12; WHO: Suizidprävention – Eine globale Herausforderung (Kurzfassung, dt. 2014); Stiftung Deutsche Depressionshilfe: Medienguide; NaSPro/DGS: Empfehlungen nach dem Suizid einer bekannten Persönlichkeit (2010). Bewusst ohne Angaben zu Methoden. Abbildungen: eigene Zeichnungen.
Zusammenfassung für den persönlichen Lerngebrauch – Luca Maranta (LM) · P1 O 25.1

Inhaltsverzeichnis

Lernheft Suizidalität · 12 Kapitel + Glossar

1 **Begriffe**
Suizid · Suizidalität · Suizidversuch · Parasuizid · Bilanzsuizid · Sprache

2 **Zahlen & Risikogruppen**
Deutschland · weltweit (WHO) · Männer/Frauen · Alter · psychische Erkrankungen

3 **Risiko- und Schutzfaktoren**
NVL Tabelle 42 · WHO-Ebenen

4 **Stadien der suizidalen Entwicklung**
Erwägung · Ambivalenz · Entschluss · präsuizidales Syndrom

5 **Alarmzeichen**
Ankündigungen · Hoffnungslosigkeit · Abschied · „Ruhe vor dem Sturm“

6 **Einschätzen und ansprechen**
Ausprägungsstufen · Screening-Fragen · Haltung · Pflicht zu handeln · Mythen

7 **Maßnahmen der Bezugspflege**
Beziehung · Sicherheit · Beobachtung · Team · Unterbringung

8 **Notfallplan und Antisuizidpakt**
Elemente · Grenzen · Bedeutung der Beziehung

9 **Wenn es doch passiert**
Team · Mitpatient*innen · Hinterbliebene

10 **Medien und Werther-Effekt**
Nachahmung · Beispiel Robert Enke · Empfehlungen für Berichterstattung

11 **Suizidprävention**
WHO-Bericht · universell, selektiv, indiziert · Zugang zu Mitteln

12 **Übungsfragen – Lösungen**
Fragen 20–24 aus dem Übungsblatt CE 11.3

A–Z **Glossar**
Fachbegriffe mit deutscher Übersetzung und Kurzerklärung

1 Begriffe

Suizid · Suizidalität · Suizidversuch · Parasuizid · Bilanzsuizid · Sprache

Begriff	Bedeutung
Suizid	= Selbsttötung: **absichtliche und aktive Beendigung des eigenen Lebens**
Suizidalität	**alle Gedanken und Handlungen**, die das Ziel haben, sich selbst zu töten – auch das **absichtliche Unterlassen lebenswichtiger Maßnahmen** (z. B. Nichteinnahme lebenswichtiger Medikamente). NVL: auch durch Handeln-Lassen oder Inkaufnehmen des Todes.
Suizidversuch	absichtliche Selbstschädigung zum Zweck der Selbsttötung, die **nicht zum Tod** führt
Parasuizid	Suizidversuch, der die Umwelt auf die verzweifelte Situation aufmerksam machen soll – **appellativ**, Aufruf zur Hilfe
Bilanzsuizid	Suizid nach scheinbar rationalem Abwägen des Für und Wider (Abgrenzung zur Sterbehilfe). Laut NaSPro wird bezweifelt, dass es ihn überhaupt gibt: Ein Suizid ist meist Endpunkt einer Krise und großer innerer Not.
erweiterter Suizid	Suizid unter Mittötung einer weiteren Person ohne deren Mitentscheidung
gemeinsamer Suizid	gemeinsam geplant und durchgeführt

> **MERKE**
>
> **Sprache prägt:** „Suizid“ oder „Selbsttötung“ sagen – nicht „Selbstmord“ (Mord unterstellt niedrige Beweggründe, ein Suizid ist keine Straftat) und nicht „Freitod“ (unterstellt eine freie Entscheidung, obwohl meist eine erlebte Ausweglosigkeit dahintersteht).

Wer Suizidgedanken hat, will meist **nicht unbedingt sterben**, sondern sieht in seiner Not keinen anderen Ausweg – der Todeswunsch ist Ausdruck subjektiv erlebter Ausweglosigkeit (NaSPro). Darin liegt die Chance für Hilfe.

> **HILFE – RUND UM DIE UHR**
>
> **TelefonSeelsorge:** 0800 111 0 111 · 0800 111 0 222 · 116 123 – kostenfrei, anonym, rund um die Uhr; auch Chat und Mail unter online.telefonseelsorge.de
> **Akute Gefahr:** Notruf **112** · in Berlin zusätzlich der Berliner Krisendienst
> Das gilt für Patient*innen, Angehörige – und für dich selbst, wenn dich das Thema belastet.

2 Zahlen & Risikogruppen

Deutschland · weltweit (WHO) · Männer/Frauen · Alter · psychische Erkrankungen

Deutschland	Weltweit (WHO 2012)
• ca. **10 000 Suizide pro Jahr** – mehr als Verkehrstote • mindestens **100 000 Suizidversuche** pro Jahr • Männer begehen **2–3-mal häufiger** Suizid (über zwei Drittel) • **Suizidversuche** sind bei **Frauen** und Jüngeren häufiger • das Risiko **steigt mit dem Lebensalter** (Ø ca. 58 Jahre; höchste Rate bei Männern > 70) • Suizid zählt zu den häufigsten Todesursachen	• ca. **804 000** Suizide im Jahr • 11,4 pro 100 000 (Männer 15,0, Frauen 8,0) • bei **15- bis 29-Jährigen** die zweithäufigste Todesursache • auf jeden Suizid kommen **mindestens 20 Suizidversuche** • Zahlen sind vermutlich zu niedrig (Stigma, falsche Einordnung)

Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen

- Bei rund **90 %** der Suizide in Deutschland liegt eine psychische Erkrankung vor (Medienguide) – v. a. **Depression**, Sucht, Psychosen, Persönlichkeitsstörungen.
- **Depression ist die Hauptursache**: 40–70 % der Suizide gehen vermutlich auf depressive Störungen zurück; die Suizidrate bei Depression ist etwa 20-mal höher (NVL).
- Ein **Suizidversuch ist der wichtigste Risikofaktor** für einen späteren Suizid (WHO): etwa jede*r Dritte unternimmt einen weiteren Versuch, etwa jede*r Zehnte stirbt später durch Suizid.
- Bei erhöhtem Risiko laut NaSPro außerdem: ältere Menschen, Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orientierung, junge Migrantinnen.

> **MERKE**
>
> Es gibt keine „harmlosen" Suizidversuche: Die Suizidforschung unterscheidet mehrheitlich nicht mehr zwischen „ernsthaften" und „nicht ernsthaften" Versuchen. **Jeder Versuch und jede Ankündigung wird ernst genommen.**

KURZ GEFRAGT

1. Wie viele Suizide gibt es jährlich in Deutschland?
2. Wer begeht häufiger Suizid, wer häufiger Suizidversuche?
3. Was ist der wichtigste Risikofaktor für einen Suizid?

Lösung: 1. ca. 10 000 · 2. Suizid: Männer (2–3-fach); Versuche: Frauen und Jüngere · 3. ein früherer Suizidversuch

3 Risiko- und Schutzfaktoren

NVL Tabelle 42 · WHO-Ebenen

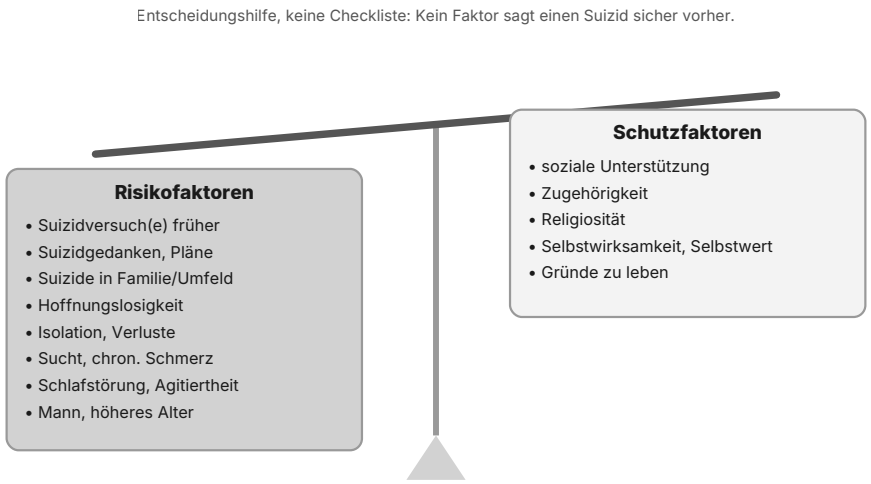


Abb. 1 Risiko- und Schutzfaktoren nach NVL Unipolare Depression (Tabelle 42, Auswahl).

Bereich	Risikofaktoren (NVL)
demografisch	männliches Geschlecht, höheres Alter (v. a. Männer > 70), niedriger sozioökonomischer Status
suizidbezogen	frühere Suizidversuche, Suizidgedanken, Pläne und Abschiedsvorbereitungen, Suizide in der Familie oder im Umfeld, **Zugang zu Mitteln**
psychosozial	Isolation, fehlende Unterstützung, Beziehungskonflikte, Verluste, Arbeitsplatzverlust, finanzielle Krisen, **Hoffnungslosigkeit**
klinisch	Sucht, chronische Schmerzen, anhaltende Schlafstörungen, Agitiertheit

Schutzfaktoren: soziale Unterstützung und Zugehörigkeit, Religiosität bzw. persönliches Glaubenssystem, Selbstwirksamkeit und Selbstwert, **Gründe zu leben**, positive Bewältigungsstrategien (WHO).

WHO-Ebenen: Risiken liegen im *Gesundheitssystem und in der Gesellschaft* (schwerer Zugang zu Hilfe, leichter Zugang zu Mitteln, sensationelle Medienberichte, Stigma), in *Gemeinde und Beziehungen* (Krieg, Diskriminierung, Isolation, Gewalt, Konflikte) und beim *Individuum* (frühere Versuche, psychische Erkrankung, Alkohol, finanzielle Verluste, chronische Schmerzen, Suizid in der Familie).

> **MERKE**
>
> Risikofaktoren sind **statistische Zusammenhänge**, keine Checkliste: Sie helfen bei der Einschätzung, sagen aber für einen einzelnen Menschen keinen Suizid sicher vorher – und kein einzelner Faktor erklärt einen Suizid allein.

4 Stadien der suizidalen Entwicklung

Erwägung · Ambivalenz · Entschluss · präsuizidales Syndrom

Suizidale Menschen durchleben häufig verschiedene Stadien (nach Pöldinger; Abb. nach Mirisch, Folie 12):

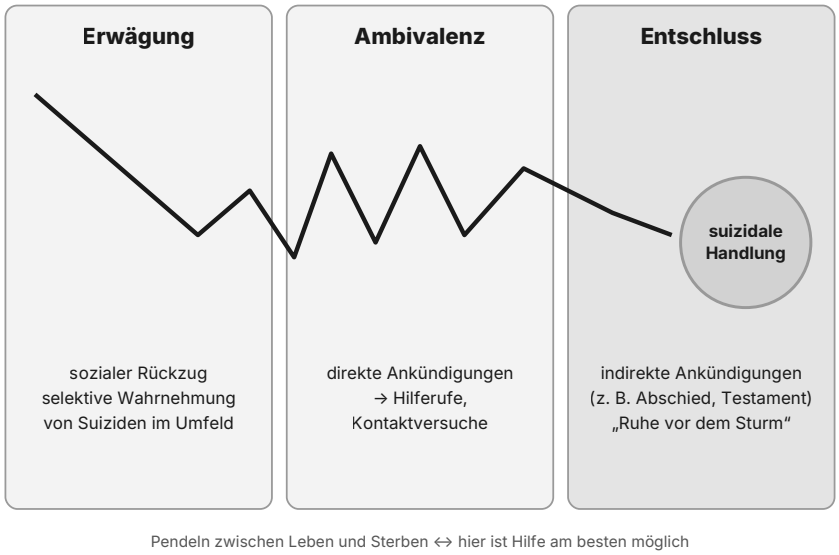


Abb. 2 Stadien der suizidalen Entwicklung. Die Ambivalenz – das Hin und Her zwischen Leben und Sterben – bietet die größte Chance für Hilfe.

Stadium	Was passiert?	Woran erkennbar?
1. Erwägung	Suizid wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen	sozialer Rückzug, selektive Wahrnehmung von Suiziden im Umfeld
2. Ambivalenz	innerer Kampf zwischen Lebens- und Todeswunsch	**direkte Ankündigungen** als Hilferufe, Kontaktversuche
3. Entschluss	Entscheidung ist gefallen, Handlung wird vorbereitet	**indirekte Ankündigungen** (z. B. überraschende Reisepläne, Testament), **„Ruhe vor dem Sturm“**

ERGÄNZUNG (NICHT AUF DER FOLIE) · PRÄSUIZIDALES SYNDROM NACH RINGEL

Der Psychiater Erwin Ringel beschrieb typische Vorstufen: **Einengung** (Denken, Gefühle, Beziehungen und Werte verengen sich, Gefühl der Ausweglosigkeit), **gehemmte und gegen sich selbst gerichtete Aggression** und **Suizidfantasien**, die sich zunehmend aufdrängen.

KURZ GEFRAGT

1. Nenne die drei Stadien der suizidalen Entwicklung.
2. In welchem Stadium ist Hilfe am besten möglich?
3. Welche Ankündigungen sind im Entschluss-Stadium typisch?

Lösung: 1. Erwägung, Ambivalenz, Entschluss · 2. Ambivalenz · 3. indirekte Ankündigungen, Ordnen von Angelegenheiten, „Ruhe vor dem Sturm“

5 Alarmzeichen

Ankündigungen · Hoffnungslosigkeit · Abschied · „Ruhe vor dem Sturm“

- **Suiziddrohungen und -ankündigungen** – Menschen, die einen Suizid beabsichtigen, kündigen ihn häufig an
- **große Hoffnungslosigkeit** und entsprechende Äußerungen: „Es hat ja doch alles keinen Sinn mehr …“, „Irgendwann muss auch mal Schluss sein …“, „Es muss jetzt was passieren …“
- **Angelegenheiten ordnen, Abschied nehmen:** Wertgegenstände verschenken, Testament aufsetzen, sich von Freunden und Verwandten verabschieden
- Hoffnungslosigkeit, Schuldgefühle, deutlicher **Verlust des Selbstwerts**
- **kompletter Rückzug** aus dem Sozialleben
- **plötzliche Stimmungsbesserung ohne erkennbaren Anlass**

ACHTUNG

„Ruhe vor dem Sturm“: Wer fest entschlossen ist, wirkt oft **ruhiger, gefestigter und weniger verzweifelt**. Die Umgebung kann zu dem trügerischen Schluss kommen, es gehe endlich wieder aufwärts. Eine Besserung ohne Grund – gerade zu Beginn einer Antidepressiva-Therapie – ist ein Alarmzeichen.

KURZ GEFRAGT

1. Nenne vier Anzeichen für einen bevorstehenden Suizid.
2. Warum ist eine plötzliche Stimmungsbesserung gefährlich?

Lösung: 1. z. B. Ankündigungen, Hoffnungslosigkeit, Abschied nehmen/Verschenken, Rückzug · 2. Sie kann bedeuten, dass der Entschluss gefasst ist („Ruhe vor dem Sturm“)

6 Einschätzen und ansprechen

Ausprägungsstufen · Screening-Fragen · Haltung · Pflicht zu handeln · Mythen

Ausprägung der Suizidalität (NVL)

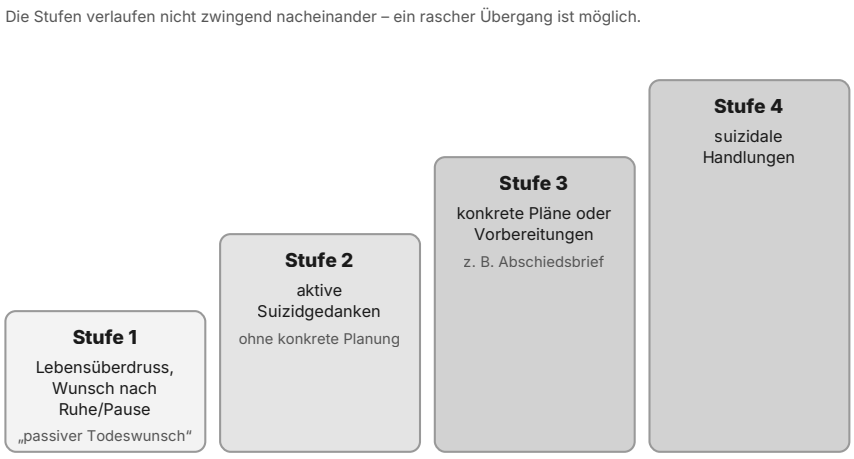


Abb. 3 Graduelle Ausprägung von Suizidalität nach NVL Unipolare Depression (Tabelle 41).

Zusätzlich werden der **aktuelle Handlungsdruck**, die **Distanzierung** vom suizidalen Verhalten und die **Absprachefähigkeit** eingeschätzt.

Offen ansprechen

Suizidalität wird in der Praxis oft nicht erfragt – aus Unbehagen oder aus Sorge, jemanden „auf die Idee zu bringen“. Studien zeigen: **Aktives Ansprechen löst Suizidalität nicht aus, sondern verringert sie eher** (NVL). Nur etwa die Hälfte der Betroffenen äußert sich von selbst.

Beispielfragen (NVL, nach P4-Screener)

- Haben Sie schon einmal versucht, sich selbst etwas anzutun?
- Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen – konkret, wann und wo?
- Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie sich in nächster Zeit tatsächlich das Leben nehmen?
- Gibt es Dinge in Ihrem Leben, die Sie davon abhalten?

Haltung im Gespräch (NVL Tabelle 40)

- Suizidalität als **Ausdruck seelischer Not** akzeptieren
- empathisch verstehen, nicht bewerten
- **entdramatisieren, aber nicht bagatellisieren**
- Hoffnung, Hilfe und Chancen auf Veränderung vermitteln
- **offen, direkt, ernst nehmend** nachfragen
- transparent über die nächsten Schritte informieren
- Zeit und Raum geben, feste weitere Kontakte vereinbaren
- Alleinsein vermeiden, Vertrauenspersonen einbeziehen

FOLIE 15 · ACHTUNG

Jeden Suizidgedanken ernst nehmen – ein vollendeter Suizid kann nie rückgängig gemacht werden. Die Annahme, geäußerte Suizidgedanken seien „nur ein Hilfeschrei“, ist falsch.

- **Ansprechen und nachfragen:** Sieht die Person Alternativen? Gibt es Ressourcen? Gibt es einen konkreten Plan → höchste Vorsicht.
- **Lage richtig einschätzen:** bei sehr schneller Entspannung wachsam sein; nimmt die Person **keinen klaren Abstand** zur Suizididee, muss etwas unternommen werden.
- **Psychiatrische Hilfe anbieten:** z. B. Klinik oder sozialpsychiatrischer Dienst.
- **Gespräch dokumentieren.**

PFLICHT ZU HANDELN

Wird Pflegenden ein Suizidwunsch geäußert, **müssen sie reagieren** – Untätigkeit kann strafbar sein (z. B. unterlassene Hilfeleistung). Informationen sofort an Ärztin/Arzt und Team weitergeben.

Mythen und Fakten

Mythos	Fakt
„Wer darüber redet, tut es nicht.“	Suizide werden **häufig angekündigt**. Jede Äußerung ernst nehmen.
„Nachfragen bringt sie erst auf die Idee.“	Offenes Ansprechen **entlastet** und senkt eher das Risiko.
„Das ist nur ein Hilferuf.“	Auch ein Hilferuf zeigt große Not – und kann tödlich enden.
„Wer es will, ist nicht aufzuhalten.“	Die meisten sind **ambivalent**; Suizide sind oft vermeidbar (WHO).
„Es geht ihr besser, die Gefahr ist vorbei.“	Plötzliche Ruhe kann ein Alarmzeichen sein.

KURZ GEFRAGT

1. Nenne die vier Ausprägungsstufen nach NVL.
2. Erhöht das Nachfragen nach Suizidgedanken das Risiko?
3. Was tust du, wenn dir ein Suizidwunsch geäußert wird?

Lösung: 1. Lebensüberdruss/passiver Todeswunsch – aktive Gedanken – konkrete Pläne/Vorbereitungen – Handlung · 2. nein, eher im Gegenteil · 3. ernst nehmen, nachfragen, nicht allein lassen, sofort Ärzt*in/Team informieren, dokumentieren

7 Maßnahmen der Bezugspflege

Beziehung · Sicherheit · Beobachtung · Team · Unterbringung

Akut suizidale Patient*innen sind ein **psychiatrischer Notfall** und werden stationär in einer (geschützten) psychiatrischen Abteilung aufgenommen. Ziel der Pflege: **Sicherheit geben, Beziehung halten, Hoffnung stärken.**

Bereich	Maßnahmen
Beziehung	**Bezugspflege** mit festen Gesprächszeiten; mehr Zeit und Präsenz (NVL: Intensivierung von Zeit und Bindung); verlässlich, ehrlich, nicht bewertend; Gefühle aushalten
Ansprechen und einschätzen	Suizidalität **regelmäßig direkt erfragen**, Ausprägung und Distanzierung einschätzen, Veränderungen bemerken (auch plötzliche Besserung)
Beobachtung	**Sichtkontrolle** nach ärztlicher Anordnung bis hin zur 1:1-Betreuung; Aufenthaltsort kennen; Absprachen zu Ausgang
sichere Umgebung	Zugang zu gefährlichen Gegenständen und Mitteln begrenzen; **Medikamenteneinnahme beobachten**, damit nichts gesammelt wird
Absprachen	gemeinsam einen **Notfallplan** erstellen; ggf. **Antisuizidpakt** (Kap. 8)
Bezugspersonen	Angehörige und Vertrauenspersonen einbeziehen, Alleinsein vermeiden
Team	alle Beobachtungen **sofort weitergeben** und **dokumentieren**; Kriseninterventionsteam; Übergaben besonders sorgfältig
Behandlung	Gabe der verordneten Medikamente (ggf. Antidepressiva, Antipsychotika, Benzodiazepine zur Beruhigung); Wirklatenz beachten (Lernheft Depression)

UNTERBRINGUNG

Fehlt die Einsicht in eine notwendige Aufnahme und besteht akute Selbstgefährdung, ist eine **Unterbringung gegen den Willen** nach dem Unterbringungsgesetz (in Berlin: PsychKG) möglich – sie ist **immer zeitlich befristet**. Details im Lernheft „Rechtliche Aspekte“.

KURZ GEFRAGT

1. Nenne fünf Maßnahmen der Bezugspflegekraft bei Suizidgefahr.
2. Warum wird die Medikamenteneinnahme beobachtet?

Lösung: 1. z. B. Beziehung und Gespräche, direkt nachfragen, Sichtkontrolle, gefährliche Mittel entfernen, Notfallplan, Angehörige einbeziehen, Team informieren, dokumentieren · 2. damit keine Tabletten gesammelt werden

8 Notfallplan und Antisuizidpakt

Elemente · Grenzen · Bedeutung der Beziehung

Antisuizidpakt

Auch Non-Suizid-Vertrag: eine **gemeinsam getroffene Vereinbarung** zwischen Patient*in und Therapeut*in bzw. Bezugsperson. Bis zu einem **festgelegten Zeitpunkt** (z. B. nächstes Gespräch) wird kein Suizidversuch unternommen; in der Not wendet sich die Person **sofort an die vereinbarte Person** oder nutzt andere vereinbarte Strategien zur Selbstrettung.

GRENZEN

Laut NVL kann ein Antisuizidpakt ein wirkungsvolles Instrument für **kurzfristige Absprachen** sein – vorausgesetzt, es besteht eine tragfähige Beziehung und ein Notfallplan. Entscheidend ist die **persönliche Verbindlichkeit**, nicht eine Unterschrift auf einem Formular. Eine **Garantie** gibt er nicht; er ersetzt nie Beobachtung und Einschätzung.

Notfallplan



Abb. 4 Elemente eines Notfallplans (NVL 12.2.1). Bei akuter Suizidgefahr soll er gemeinsam mit der Person erstellt werden.

Für Notfallpläne gibt es Belege, dass sie suizidales Verhalten verringern (NVL: starke Empfehlung). Wichtig ist die **gemeinsame Erarbeitung** in den Worten der Patientin bzw. des Patienten.

9 Wenn es doch passiert

Team · Mitpatient*innen · Hinterbliebene

Trotz aller Bemühungen kann ein Suizid passieren – im Ausgang, auf Station oder nach der Entlassung.

Hilfen für das Team

- regelmäßige **Supervision**, Fallbesprechung
- kollegialer Austausch, nicht allein bleiben
- Gespräche im privaten Umfeld
- therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen
- Nähe und Distanz dauerhaft reflektieren

Hilfen für Mitpatient*innen

- **offener Austausch** statt Schweigen
- Gesprächsangebote, aktiv auf Betroffene zugehen
- auf eigene Suizidalität achten (Nachahmungsgefahr)

Hinterbliebene

Von jedem Suizid sind mindestens **sechs Menschen** stark betroffen; die Trauer kann Jahre dauern. Sie sind selbst eine Risikogruppe (WHO).

10 Medien und Werther-Effekt

Nachahmung · Beispiel Robert Enke · Empfehlungen für Berichterstattung

> **Werther-Effekt:** Nach ausführlicher, emotionaler Medienberichterstattung über einen Suizid steigt die Zahl der Suizide in der Bevölkerung. Der Name geht auf eine „Suizidwelle" nach Goethes Roman *Die Leiden des jungen Werthers* (1774) zurück.

- Medien beeinflussen viele Menschen und prägen die Sprache. Besonders gefährdet sind Menschen, die bereits suizidgefährdet sind oder sich mit der verstorbenen Person verbunden fühlen.
- Seit 1997 gibt es eine Richtlinie des **Deutschen Presserats** – nicht alle Medien halten sich daran.
- Bei **prominenten Personen** ist der Effekt besonders stark.

BEISPIEL ROBERT ENKE (2009)

Der Nationaltorwart litt an einer nicht öffentlich bekannten Depression. Nach seinem Suizid im November 2009 berichteten Medien sehr ausführlich, auch über Details des Ortes und Ablaufs; die Trauerfeier wurde live übertragen. In den folgenden Tagen stiegen die Suizide nach gleichem Muster deutlich an – laut Folie allein Mitte November etwa um das Vierfache –, erneut auch nach der Gedenkfeier.

Was die Nachahmungsgefahr erhöht und senkt (Medienguide, NaSPro)

Gefahr steigt, wenn …	Gefahr sinkt, wenn …
• groß aufgemacht (Titel, Schlagzeile, Fotos) • „Selbstmord", „Freitod" in der Überschrift • Methode oder Ort detailliert beschrieben • Motive ergreifend dargestellt, Abschiedsbriefe veröffentlicht • Suizid als nachvollziehbar, einziger Ausweg oder romantisch dargestellt • prominente Person	• Suizid als Folge einer **behandelbaren Erkrankung** dargestellt • Auswege und Bewältigung gezeigt • **Hilfsangebote** und Telefonnummern genannt • Hintergrund zu Depression und Arbeit von Helfern • keine einfachen Erklärungen, keine Schuldzuweisungen

Ein Beispiel für die Wirkung: In Wien gingen U-Bahn-Suizide um mehr als 70 % zurück, nachdem Journalisten ab 1987 zurückhaltender berichteten.

> **MERKE FÜR DICH**
>
> Auch im Alltag und in sozialen Medien gilt: **keine Details zu Methoden oder Orten** weitergeben, keine Bilder teilen – stattdessen auf Hilfsangebote hinweisen.

11 Suizidprävention

WHO-Bericht · universell, selektiv, indiziert · Zugang zu Mitteln

Die WHO (Bericht „Suizidprävention: Eine globale Herausforderung“, 2014) betont: **Suizide sind vermeidbar.** Viele geschehen aus einem Impuls heraus – deshalb kann schon die Verfügbarkeit von Mitteln über Leben und Tod entscheiden. Ziel des WHO-Aktionsplans 2013–2020: die Suizidrate in allen Ländern um **10 %** senken.



Abb. 5 Drei Ebenen der Suizidprävention nach WHO.

- **Zugang zu tödlichen Mitteln beschränken** ist eine der wirksamsten Maßnahmen (z. B. Absicherung von Bauwerken, kleinere Packungsgrößen bestimmter Medikamente).
- Psychische Erkrankungen und Alkoholmissbrauch früh erkennen und behandeln; Gesundheitspersonal schulen.
- **Stigma abbauen**, damit Menschen Hilfe suchen; verantwortungsvolle Medienberichterstattung.
- **Nachsorge** nach einem Suizidversuch und nach Entlassung; Unterstützung für Hinterbliebene.
- Gemeinden, Familien und soziales Umfeld stärken (Resilienz); **Welttag der Suizidprävention: 10. September**.

> **HILFE – RUND UM DIE UHR**
>
> **TelefonSeelsorge:** 0800 111 0 111 · 0800 111 0 222 · 116 123 – kostenfrei, anonym, rund um die Uhr; auch Chat und Mail unter online.telefonseelsorge.de
> **Akute Gefahr:** Notruf **112** · in Berlin zusätzlich der Berliner Krisendienst
> Das gilt für Patient*innen, Angehörige – und für dich selbst, wenn dich das Thema belastet.

12 Übungsfragen – Lösungen

Fragen 20–24 aus dem Übungsblatt CE 11.3

Frage	Lösung
20. Was versteht man unter Suizidalität?	Alle Gedanken und Handlungen, die das Ziel haben, sich selbst zu töten – auch das absichtliche Unterlassen lebenswichtiger Maßnahmen (z. B. lebenswichtige Medikamente nicht nehmen). Sie reicht vom Lebensüberdruss über aktive Suizidgedanken und konkrete Pläne bis zur suizidalen Handlung (NVL-Stufen 1–4).
21. Welche Stadien eines Suizids kennen Sie?	1. **Erwägung** (Rückzug, selektive Wahrnehmung von Suiziden) · 2. **Ambivalenz** (Hin und Her, direkte Ankündigungen als Hilferufe) · 3. **Entschluss** (indirekte Ankündigungen, Ordnen von Angelegenheiten, „Ruhe vor dem Sturm“) → suizidale Handlung.
22. Was sind mögliche Anzeichen für einen bevorstehenden Suizid?	Suiziddrohungen und -ankündigungen; große Hoffnungslosigkeit („Es hat alles keinen Sinn mehr“); Angelegenheiten ordnen, Abschied nehmen, Wertsachen verschenken, Testament; kompletter sozialer Rückzug; Schuldgefühle, Selbstwertverlust; plötzliche Stimmungsbesserung ohne Anlass („Ruhe vor dem Sturm“); konkrete Pläne oder Vorbereitungen.
23. Welche Maßnahmen kann die Bezugspflegekraft ergreifen, um einen möglichen Suizid abzuwenden?	Tragfähige Beziehung, feste Gesprächszeiten, Zeit und Präsenz; Suizidalität offen und direkt ansprechen und regelmäßig einschätzen; Sichtkontrolle/engmaschige Beobachtung nach Anordnung; gefährliche Gegenstände und Mittel entfernen, Medikamenteneinnahme kontrollieren; Notfallplan und ggf. Antisuizidpakt; Angehörige einbeziehen, Alleinsein vermeiden; alle Beobachtungen sofort an Ärzt*in und Team weitergeben und dokumentieren; Hoffnung vermitteln; bei fehlender Einsicht und akuter Gefahr Unterbringung einleiten lassen.
24. Was versteht man unter einem Antisuizid-Pakt?	Eine gemeinsam getroffene, verbindliche Vereinbarung zwischen Patient*in und Therapeut*in/Bezugsperson: Bis zu einem festgelegten Zeitpunkt wird kein Suizidversuch unternommen; in der Not meldet sich die Person sofort bzw. nutzt vereinbarte Strategien. Er setzt eine tragfähige Beziehung voraus, ist kein Formular zur Absicherung und keine Garantie.

HILFE – RUND UM DIE UHR

TelefonSeelsorge: 0800 111 0 111 · 0800 111 0 222 · 116 123 – kostenfrei, anonym, rund um die Uhr; auch Chat und Mail unter online.telefonseelsorge.de

Akute Gefahr: Notruf **112** · in Berlin zusätzlich der Berliner Krisendienst

Das gilt für Patient*innen, Angehörige – und für dich selbst, wenn dich das Thema belastet.

Glossar

Fachwort · deutscher Begriff · Kurzerklärung

Fachwort	Deutscher Begriff
Ambivalenz	Zwiespalt Pendeln zwischen Lebens- und Todeswunsch; Stadium, in dem Hilfe besonders gut möglich ist.
Antisuizidpakt	Nicht-Suizid-Vereinbarung Gemeinsame Absprache: bis zu einem festen Zeitpunkt keine suizidale Handlung, in der Not sofort Kontakt.
Bilanzsuizid	Suizid nach „Abwägung“ Suizid nach scheinbar rationaler Abwägung; laut Suizidforschung zweifelhaft, da meist innere Not dahintersteht.
Erweiterter Suizid	Suizid mit Mittötung Suizid, bei dem eine weitere Person ohne deren Entscheidung mit getötet wird.
Hinterbliebene	Angehörige nach Suizid Nahestehende eines durch Suizid Verstorbenen; pro Suizid mindestens 6 Menschen stark betroffen.
Krisenintervention	Hilfe in der akuten Krise Kurzfristige, intensive Unterstützung zur Abwendung akuter Gefahr.
Notfallplan	Krisenplan Gemeinsam erstellter Plan mit Warnzeichen, Strategien, Kontakten und Zugangsbeschränkung zu gefährlichen Mitteln.
Parasuizid	appellativer Suizidversuch Suizidversuch, der die Umwelt auf die verzweifelte Lage aufmerksam machen soll – Hilferuf.
Präsuizidales Syndrom	Vorstufe nach Ringel Einengung, gehemmte und gegen sich gerichtete Aggression, Suizidfantasien.
Ruhe vor dem Sturm	trügerische Beruhigung Plötzliche Entspannung nach gefasstem Entschluss – Alarmzeichen.
Sichtkontrolle	regelmäßige Beobachtung Engmaschige Kontrolle des Aufenthalts und Befindens bei akuter Suizidalität.
Suizid	Selbsttötung Absichtliche und aktive Beendigung des eigenen Lebens.
Suizidalität	Selbsttötungsgefährdung Alle Gedanken und Handlungen mit dem Ziel, sich selbst zu töten – auch das absichtliche Unterlassen lebenswichtiger Maßnahmen.
Suizidprävention	Vorbeugung von Suiziden Maßnahmen auf Ebene der Bevölkerung, von Risikogruppen und Einzelnen (WHO).
Suizidversuch	versuchte Selbsttötung Absichtliche Selbstschädigung mit dem Ziel der Selbsttötung, die nicht zum Tod führt.
Unterbringung	Zwangseinweisung Aufnahme in eine geschlossene Station gegen den Willen bei akuter Selbstgefährdung; zeitlich befristet.
Werther-Effekt	Nachahmungseffekt Anstieg von Suiziden nach ausführlicher, sensationeller Medienberichterstattung.

Quellen: Folien M. Pahler (BBG) · NVL Unipolare Depression 3.2 · WHO 2014 · Medienguide · NaSPro/DGS 2010.